



נוהל מסי:	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

תאריך פרסום: 1.6.2018	תחום הנוהל :	
	שם הנוהל : שהייה משותפת אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
נספחים : 1. טופס הסבר על אפס הפרדה 2. דף מידע להורים בדבר טיפול בילוד	מאשר הנוהל : פרופ' א. קוגלמן מנהל טיפול נמרץ פגים וילודים	כותב הנוהל : צוות ניהולי חטיבת מיילדות גינקולוגיה
	על החתום : פרופ' א. קוגלמן	על החתום :
	תפוצה : • מנהל אגף נשים וילדות • מנהל ט. נמרץ פגים וילודים • מנהלת הסיעוד חטיבת מיילדות גניקולוגיה	
	מחלקות : • ילודים • יולדות • חדר לידה • נשים • ט.נ. פגים • חדר ניתוח	
	אחראית תחום סיעוד בחטיבה מיילדותית: גב' מיכל קרנצלר על החתום: מיכל קרנצלר	

רשימת עדכונים:

מהדורה	מהות העדכון	שם המעדכן ותפקיד	תאריך

מילות מפתח (KEY WORDS):

אפס הפרדה, מגע עור לעור, ניתוח קיסרי, לידה, ילוד, אם
--



נוהל מסי:	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

רקע:

אנו מכירים בחשיבות השהייה המשותפת של האם לילוד לאחר הלידה אשר מקדמת את בריאות האם והיילוד והתקשורת ביניהם ומובילה להצלחה בהנקה. בניית תהליך מבוקר ושיטתי יבטיח טיפול איכותי ובטוח לאם ולילוד.

1. מטרת הנוהל:

- 1.1. לאפשר אפס הפרדה תוך שמירת בטיחות האם והילוד
- 1.2. קידום בריאות האם והילוד
- 1.3. עידוד הנקה וביסוסה
- 1.4. מתן מענה לצרכי היולדת
- 1.5. קידום חזון בית חולים "אתך בדרך שלך"

2. הגדרות ומונחים

- 2.1. אפס הפרדה: שהות של הילוד עם האם בהשגחתה וטיפוליה מרגע הלידה ועד השחרור עור לעור: מגע ישיר עור לעור של ילוד עם אמו או אביו.

3.2 קריטריונים לאי ביצוע - אפס הפרדה מבחינת הילוד:

- 3.2.1 סימני תחלואה כמו קשיי נשימה, תינוק לא יציב, כחלון או סימנים למצוקה נשימתית
- 3.2.2 מום טרום לידתי לתינוק שעלול להשפיע על התפקוד שלו – על פי שיקול רפואי. רופא ילדים ייקרא ללידה לבדיקת הילוד ויחליט
- 3.2.3 היסטוריה משפחתית ברת סיכון
- 3.2.4 כל שינוי במצב הילוד על פי החלטה קלינית (כמו צהבת הדורשת טיפול באור)
- 3.2.5 קבוצת סיכון להיפוגליקמיה:

LGA >4000, SGA <2500

LATE PRETGRM 34-36.6 weeks

אמא מטופלת באינסולין IDDM, GDM

- 3.2.7 תינוקות בשבוע 37 ומטה – פגות
- 3.2.8 גורם סיכון לזיהום המחייב טיפול אנטיביוטי והשגחה רפואית

3.3 קריטריונים לאי ביצוע אפס הפרדה מבחינת האם:

- 3.3.1 אימא עם מחלת רקע שמשפיעה על רמת ההכרה וההתמצאות
- 3.3.2 כל שינוי במצב היולדת שמצריך טיפול דחוף
- 3.3.3 מחלות זיהומי בעלות סיכון הדבקה גבוהה כמו שחפת, אבעבועות רוח ועוד



נוהל מס':	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

4 סמכות ואחריות:

הגדרת תחומי האחריות/סמכות	הגורם
הסבר לאם על תהליך אפס הפרדה ומעקב על הילוד, דיווח ותיעוד ברשומה.	4.1 מיילדת
הסבר ליווי ומעקב אחר הילוד ותיעוד ברשומה.	4.2 אחות
החלטה על הוראת נגד לאפס הפרדה ותיעוד	4.3 רופא ילדים

5 שיטת הביצוע/הנחיות:

- 5.1 הליך:
- 5.1.1 עם קבלת היולדת יש לקיים תיאום ציפיות באמצעות חוברת תוכנית לידה תוך התייחסות לאפס הפרדה ודיווח ברשומה הסיעודית במקום הייעודי.
- 5.1.2 מתן מידע ליולדת וטפסי הסבר (נספח מס' 1)
- 5.2 הלידה:
- 5.2.1 מיד לאחר הלידה התינוק יונח על אמו במגע עור לעור לפי בחירת היולדת.
- 5.2.2 מתן הדרכה להנקה
- 5.2.3 הסבר על חשיבות מגע עור לעור
- 5.2.4 בחדר הלידה תינוק ישהה לצד אמו או מלווה משמעותי אחר, במידה וישנו שינוי במצב היולדת והילוד יש לשקול תכנית המשך אפס הפרדה
- 5.3 מעקב ילוד בחדר לידה:
- 5.3.1 אומדן - צבע, נשימה, טונוס, סיוע בהנקה, הדרכת יולדת בנושא בטיחות, מגע עור לעור ע"י מיילדת אחת לשעה.
- 5.3.2 דיווח ברשומה
- 5.3.3 זיהוי ילוד עפ"י תגים וסיכום לידה- וחתומה על סיכום לידה.
- 5.4 מעקב בילודים:
- 5.4.1 3 פעמים במשמרת לפחות ולפי מצב הילוד- יבדקו
- 5.4.2 זיהוי תגים
- 5.4.3 מצב הילוד – צבע ונשימה
- 5.4.4 אומדן תזונה
- 5.4.5 הידרציה – יציאות, שתן
- 5.4.6 רמת סוכר בהתאם לנוהל גלוקוז
- 5.4.7 צהבת



נוהל מסי:	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

5.5 דווח במקום הייעודי להוצאת תינוק בפעם הראשונה וטופס החתמה על בטיחות

5.6 אומדן צורכי הדרכה לילודת

5.7 מהלך אשפוז:

5.7.1 בדיקת רופא, אפשרות לנוכחות היולדת / המלווה בביקור רופא של הילוד. לפחות בדיקה אחת לאחר הקבלה ואחת בטרם שיחרור

5.8 העברה מחדר לידה למחלקות:

5.8.1 תינוק יכול לעבור למחלקת תינוקות בליווי איש צוות מחדר לידה בנוכחות מלווה / או האם (אם מצבה מאפשר זאת).

5.8.2 על המיילדת לידע את מחלקת יולדות ותינוקות, לגבי העברת היולדת והילוד למחלקה.

5.8.3 ההעברה בין מחלקות נעשית בעריסה ויתבצע תהליך זיהוי ילוד במעמד קבלתו במחלקה (- לפי נוהל זיהוי ילוד).

5.8.4 תעשה העברת "מקל" מסודרת בין איש צוות חדר לידה לאחות בילודים. ודיווח על פי ISBAR

5.9 תהליך הקבלה והטיפול הראשוני יעשו בנוכחות האב ו / או האם (אם מצבה מאפשר זאת).

5.10 טיפולים ובדיקות יעשו על משטח ההחתלה או משטח העריסה בקרבת ההורה.

5.11 במקרה של סירוב טיפול מצד ההורים יש להחתים אותם על סירוב טיפול כמקובל לאחר הסבר המשמעות והסיכונים לתינוק. החתמת היולדת על טופס ייעודי (נספח 2)

5.12 בדיקת רופא לאחר לידה ולפני שחרור יעשו במחלקה

5.13 תינוק לאחר ניתוח קיסרי:

5.13.1 יש לאפשר נוכחות מלווה ביממה הראשונה.

5.13.2 יתקבל למחלקה לטיפול ראשוני ויצא למלווה בהחלטת אחות. מלווה יודרך לדווח לצוות על כל שינוי במצב הילוד. על התינוק לחזור למחלקת תינוקות תוך שעתיים להסתכלות של אחות ובדיקת סימנים חיוניים בהתאם לצורך.

5.14 הנחיות כלליות:

5.14.1 בחדר לידה ההורים יקבלו דף הסבר לגבי הטיפול הראשוני הניתן לתינוק במחלקת תינוקות. ההורים אמורים לחתום על הסכמה / אי הסכמה לטיפול ובהתאם לכך יינתן הטיפול במחלקה. (נספח- דף מידע להורים בדבר טיפול בילוד).

5.14.2 מלווה אישה תוכל להישאר במחלקת יולדות בחדר היולדת למשך 24

שעות. מלווה גבר יוכל להישאר במחלקת יולדות בחדר היולדת בין השעות 8:00 – 21:00 (למעט בזמני ביקור רופאים ומנוחת יולדות).



רמב"ם

הקרית הרפואית לבריאות האדם

נוהל מס':	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

5.14.3 לאורך האשפוז, בכל מצב בו התינוק צריך להישאר להשגחה או טיפול במחלקה, אחד ההורים רשאי להיות נוכח לביקורים קצובים ליד התינוק ועל פי שיקול דעת אחראית המשמרת.

6 דיווח ותיעוד:

6.1 דיווח ברשומה הסיעודית:

6.1.1 דיווח בחדר לידה על בחירת האם.

6.1.2 במחלקת ילודים ידווח על מצב התינוק והמעקב הרציף.

6.1.3 דיווח ברשומת של היולדות ביולדות.



נוהל מסי':	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

נספח מספר 1

טופס הסבר בנושא אפס הפרדה

- **אפס הפרדה** הינו מצב בו האם והתינוק שוהים יחדיו מרגע הלידה ולאורך כל האשפוז ועד השחרור.
- בהגיעך לחדר הלידה, את נדרשת לידע את הצוות בבחירתך לגבי אפס הפרדה.
- לאחר לידת התינוק, את ותינוקך תשהו במגע עור לעור. מלבד מצבים שבהן מצב הילוד או מצבך אינן מאפשרים זאת, וזה לאחר הערכת הצוות הסיעודי והרפואי.
- מלווה משמעותי עבורך יכול לשהות עם התינוק במידה ואינך חשה בטוב.
- לאחר ההתאוששות שלאחר הלידה בערך כשעתיים, את ותינוקך תועברו למחלקת יולדות, שם יקבלו את פניכן אחות ממחלקת יולדות ואחות ממחלקת ילודים.
- בתהליך הקבלה למחלקה תקבלי הסבר על המשך הטיפולים בך ובילוד.
- הטיפולים הראשוניים של הילוד ולאחר מתן הסכמתכם, יתקיימו במחלקה בנוכחותך או בנוכחות מלווה משמעותי אחר.
- במהלך האשפוז, תינוקך ישהה איתך בכל שעות היממה תקבלי הדרכה, במידה ותידרש הדרכה נוספת בטיפול בילוד, תוכלי לפנות למחלקת ילודים.
- במהלך האשפוז טיפולים ובדיקות בתינוקך יעשו בנוכחותך, חלק מהטיפולים יעשו כשהתינוק מונח על גופך וחלק מטעמי בטיחות יעשו בעמדה ייעודית לכך במחלקה.

בברכת מזל טוב



נוהל מסי:	
שם הנוהל: שהייה משותפת, אם ילוד מרגע הלידה ועד השחרור (אפס הפרדה בין אם לילוד)	
JCI CODE	

נספח 2



מדבקת אם או תינוק

דף מידע לאם/להורים בדבר הטיפול בילוד

אנו מבקשים להביא לידיעתך כי הילוד שיוולד לך/לכם במזל טוב, יתקבל להשגחה וטיפול במחלקת ילודים או פגים. כדבר שבשגרה מתבצעות במחלקת ילודים הבדיקות והפעולות הבאות.

מסרבת חתימה: _____	מתן חיסון ראשון נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B: על פי המלצת משקד הבריאות מחסנים את כל הילודים בארץ נגד דלקת כבד זיהומית מסוג B. חיסון זה ניתן סמוך ללידה ובתינוקות עם משקל לידה נמוך לאחר שהגיעו למשקל 2.0 ק"ג.
מסרבת חתימה: _____	הזרקת ויטמין K תוך שרירית: ויטמין K חיוני להפעלה תקינה של מערכת קרישת הדם ולמניעת דימומים. כל כילודים במדינה וברוב ארצות העולם מקבלים זריקה זו סמוך ללידה.
מסרבת חתימה: _____	טיפות עיניים: טיפות (אריתרומיצין) הניתנות באופן חד פעמי לכל הילודים למניעת דלקות עיניים קשות שמקורן בתעלת הלידה.
מסרבת חתימה: _____	בדיקת סיקור: גילוי מוקדם של 11 מחלות (פנילקטוריה, תת תריסיות ראשונית מולדת ועוד), מאפשר טיפול בזמן ובהתאם, ומניעה של התפתחות לא תקינה של התינוק בעתיד. לצורך בדיקות אלו נלקחת דגימת דם מן העקב ביום השני או השלישי לחיים. (בדיקות אלה אינן שוללות קיומן של מחלות אלה במאת האחוזים / או המחלות אחרות)
מסרבת חתימה: _____	בדיקת סקר לסינון שמיעה: כל ילוד טרם שחרור עובר בדית סינון שמיעה ביומו השני או לקראת השחרור לצורך איתור מוקדם ככול האפשר של ליקוי שמיעה. במידה ובשל חגים או סוף שבוע הבדיקה לא תתבצע, תתואם בדירה במועד אחר במסגרת מחלקת ילודים/פגים.
מסרבת חתימה: _____	רחצה ראשונית: תתבצע עם קבלת הילוד במחלקת ילודים/פגים. מיועדת להסרת שאריות הדם והפרשות היולדת מגוף הילוד.

במקרים חריגים בהם את מסרבת על אף ההסברים שקיבלת על מתן טיפול מסויים, אנא הודיעי לנו והקיפי בעיגול את המילה "מסרבת" בטבלה למעלה וחיתמי לידה. טיפול זה לא יינתן ורופא מחלקת ילודים/פגים יסביר לך את המשמעויות לכך בהקדם האפשרי.

אי מתן הודעת הסירוב כאמור, תחשב כהסכמה למתן הטיפולים.

שם היולדת: _____ ת.ז: _____ חתימה: _____

שם האב האפטרופוס אחר (במקרה והאם אינה מסוגלת לחתום):

שם: _____ ת.ז: _____ חתימה: _____

שם המיילדת/ האחות: _____ חתימה: _____